



UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

HISTORIA CLÍNICA

Generado en: Friday, June 26, 2026 10:21 AM

Solicitado por: Ana Diagnostico

I PARTE: DATOS DEL/LA PACIENTE
Documento de Identificación: CI 5000001
Nombre completo: María Fernanda Rendón Caballero Navarro Espino
Fecha de Nacimiento Día: 09 Mes: 02 Año: 1974 Edad: 52 Sexo: Femenino
Lugar de Nacimiento: País: Bolivia Departamento: Santa Cruz Distrito: Distrito 1 Nacionalidad: Boliviana Etnia: Mestiza Estado civil: Casado
Nivel educativo: Secundaria concluida Años cursados: Situación laboral:

II PARTE: ANAMNESIS

Motivo de Consulta:

asdf

Historia de la enfermedad actual

asdf

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS
Hábito Tabáquico: Anteriormente fumaba Consumo de Alcohol: Consumo de riesgo (mas de 2 botellas de cerveza) ¿Realiza actividad física al menos 150 min a la semana?: NO ¿Cuántas porciones consume de frutas y/o verduras al día en una semana normal? 1 - 2 porciones al día

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES		
Enfermedad	Fecha de diagnóstico	Tratamiento

III PARTE: EXAMEN FÍSICO											
SIGNOS VITALES Y DATOS ANTROPOMÉTRICOS											
PA Miembros superiores			Pulsos	FR	FC	T° Axilar	Peso	Talla	IMC	Perímetro de cadera	Perímetro de cintura
	Máx	Min								12	12
Der.	12	12									
Izq	12	12									
PA media	12		12	12	12	12	12	833.33	Índice cintura cadera	1	
Diagnostico a partir del IMC: Riesgo de desnutrición											

Inspección, Palpación, Percusión, Auscultación (I.P.P.A)

CABEZA	asdf
CUELLO	asfd
APARATO RESPIRATORIO	afd
APARATO CARDIOVASCULAR	asdf
ABDOMEN Y PELVIS	asdf
APARATO GÉNITO URINARIO	asdf
PIEL Y FANERAS	asdf
SISTEMA HEMOLINFOPOYÉTICO	asdf
APARATO OSTEOARTROMUSCULAR	asdf
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL	asdf

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

ELECTROCARDIOGRAMA

Ritmo:

FC:

Crecimiento de aurícula derecha:

Crecimiento de aurícula izquierda:

Crecimiento de ventrículo derecho:

Crecimiento de ventrículo izquierdo:

Intervalo PR:

Intervalo QTc:

Supra o infra desnivel del segmento ST:

Derivación del desnivel:

Duración de la onda P:

Duración del complejo QRS:

Duración de la onda T:

Extrasístole supraventricular:

Extrasístole intraventricular:

Diagnóstico Electrocardiógrafo:

ESPIRÓMETRIA

FEV1:

Porcentaje de FEV teórico:

FVC:

Porcentaje de FVC teórico:

FEV 1/FVC:

Porcentaje del FEV 1/FVC teórico:

Flujo espiratorio pico PEF en lt:

Porcentaje PEF teórico:

Fuente de datos teóricos:

Observaciones:

Diagnóstico espirométrico:

ECOGRAFÍA ABDOMINAL Y RENAL

ECOGRAFÍA DE ABDOMEN

Hígado:

Dimensiones en mm: 12

Hepatomegalia: false

Parénquima: Heterogeneo

Diagnóstico ecográfico: asdf

Vesícula biliar:

Paredes: Irregulares

Contenido anecoico: false

Barro biliar: false

Calculos en su interior: false

Diagnóstico ecográfico: asdf

Riñones:

Medida longitudinal en mm:

RD: 12 RI: 12

Medida del parénquima en mm:

RD: 12 RI: 12

Ecogenicidad: Aumentada

Relacion cortico medular: Aumentada

Diagnóstico ecográfico: asdf

LABORATORIO

Glicemia Capilar:

Grupo Sanguíneo:

Otros estudios:

IV PARTE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

Principal: Tuberculosis miocárdica

Secundarios:

Plan de trabajo: sadfljkasjdkfl

TRATAMIENTO